TEMA 22 · Indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos por enfermeras. RD 954/2015 y acreditación

Resumen OPE Enfermería SMS · Marco legal, orden de dispensación, artículos 2 y 3 del RD 954/2015, STC 76/2018 y RD 1302/2018, acreditación y REPS, acreditación en el SMS, guías nacionales, protocolos regionales del SMS y farmacovigilancia

1. Marco legal

Norma	Clave
CE art. 149.1.16.ª	Competencia **exclusiva del Estado** en bases de la sanidad y legislación de productos farmacéuticos
Ley 44/2003 (LOPS)	Ordenación de las profesiones sanitarias; la prescripción seguía ligada a los médicos
Ley 29/2006 (modificada por la **Ley 28/2009**)	Punto de inflexión: participación de la enfermería en la cadena del medicamento (hoy **derogada**)
RDL 1/2015	**Texto refundido de la Ley de garantías y uso racional** de los medicamentos: norma vigente de rango superior
RD 1718/2010	Receta médica y **órdenes de dispensación**
RD 954/2015	Indicación, uso y autorización de dispensación por **enfermeros**
RD 1302/2018	Modifica el RD 954/2015 tras la **STC 76/2018**

- "**Prescripción**" y "**receta médica**" están reservadas a **médicos, odontólogos y podólogos**. La enfermería **indica, usa y autoriza la dispensación** mediante la **orden de dispensación**.
- **Orden de dispensación**: datos del paciente (nombre, año de nacimiento, DNI o tarjeta), del medicamento (denominación, dosis, forma, vía, formato, envases, posología), del enfermero (identificación y **firma**) y fechas. **Validez: 10 días naturales** desde la emisión o la fecha prevista de dispensación.

2. RD 954/2015

	Art. 2: medicamentos **no sujetos** a prescripción y **productos sanitarios**	**Art. 3**: medicamentos **sujetos** a prescripción (símbolo **"O"** en el envase)
Autonomía	**Autónoma** (juicio y diagnóstico enfermero)	**Colaborativa**
Requisitos	**Acreditación**	Acreditación + **guía nacional** validada + **protocolo** autonómico
Diagnóstico	Enfermero (NANDA)	**Diagnóstico y prescripción médica inicial** (regla general); la enfermera hace el seguimiento: prorrogar, ajustar dosis dentro de márgenes o suspender

- **Guías (art. 6)**: las elabora un grupo de trabajo **paritario** de la **Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial** (Ministerio, CC. AA., mutualidades, Consejo General de Enfermería y Organización Médica Colegial); las valida la **Dirección General de Salud Pública** y se publican en el **BOE**. Después, cada servicio de salud debe **adaptarlas en un protocolo** para poder aplicarlas.
- **STC 76/2018 (5 de julio)**: anula aspectos que invadían la competencia autonómica de **acreditación**. El **RD 1302/2018 (22 de octubre)** consolida el "**marcado carácter colaborativo**" (no hace falta validación médica individual de cada acto si hay protocolo) e introduce la **excepción de las vacunas**: las del **calendario y las campañas de salud pública** solo requieren **orden de dispensación enfermera**, **salvo** que el paciente, por sus condiciones particulares, precise **valoración médica individualizada**. También prevé formación complementaria para medicamentos de especial complejidad.

3. Acreditación

- **Requisitos (art. 9)**: título de Enfermería (y de especialista, en su caso) y **uno** de estos: **1 año de experiencia** (cuentan todos los servicios, **públicos o privados**) o **curso de adaptación gratuito** (ECTS).
- La **acredita la Comunidad Autónoma**; se inscribe en el **Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS)** del Ministerio, que le da **validez en todo el territorio**. Vigencia **indefinida**, salvo **suspensión o revocación** por pérdida de requisitos, sanción disciplinaria firme o inhabilitación judicial (se comunica al REPS).
- **Cuidados generales**: medicamentos sin receta, productos sanitarios y guías generales. **Especialistas** (matrona, salud mental, pediatría, etc.): con receta, **solo** en las guías de su especialidad.

En la Región de Murcia	
Inicio	**Resolución de 30 de septiembre de 2022** (afecta a la sanidad pública y privada)
Quién acredita	El **Director Gerente del SMS** (por delegación de la Consejería)
Personal del SMS	**De oficio**, sin solicitud; primera resolución en el **BORM del 30 de enero de 2023** (anexo I: cuidados generales; II: especializados); actualizaciones **mensuales**; certificado en el **Portal del Empleado**
Sanidad privada	**Procedimiento 3460** de la sede electrónica de la CARM: certificado de la empresa o declaración responsable (autónomos), **sin tasas**, resolución en **6 meses** con **silencio positivo**; **recurso de alzada** ante la Consejería en **1 mes**

4. Guías nacionales del Ministerio

Guía	Contenido destacado
Heridas (2020, la primera)	Tratamiento tópico de heridas agudas y crónicas
HTA y diabetes 1 y 2 (2022)	**Prorrogar** el tratamiento crónico y **ajustar dosis dentro de los rangos** fijados por el médico (no cambiar de grupo); suspender y derivar ante alarma; glucagón en urgencias
Quemaduras (2022)	**Corticoides tópicos** (grupo D07AC) solo para **complicaciones**: alergia local, **hipergranulación**, cicatrices hipertróficas y queloides; comprobar la financiación en **BIFIMED**
Ostomías (2023)	Productos barrera y tópicos por consenso de expertos
Anticoagulación oral (2023)	Antivitamina K (**acenocumarol**, warfarina; inhiben los factores **II, VII, IX y X**). **INR diana 2-3** (2,5-3,5 en válvulas mecánicas); < 2: subir dosis; > 3: bajar; muy alto: **vitamina K**
Fiebre (2024)	**Paracetamol e ibuprofeno**
Deshabituación tabáquica (2024)	**Vareniclina** y **citisiniclina**
Anestésicos locales (2024)	Amidas (llevan "i" antes de "-caína": **lidocaína, bupivacaína, mepivacaína**) y ésteres (**tetracaína**); excluidos los parches de lidocaína de la neuralgia posherpética. **Toxicidad sistémica (LAST)**: sabor metálico, acúfenos, parestesias peribucales, agitación, arritmias → **suspender, soporte vital y avisar**
ITU inferior en mujeres (2024)	Cistitis no complicada en mujeres no gestantes: **fosfomicina 3 g** o **nitrofurantoína**, solo si las **resistencias locales de *E. coli*** son bajas

5. Protocolos regionales del SMS

- Aprobados por la **Comisión Regional de Farmacia y Terapéutica** el **15 de diciembre de 2023** y publicados en **septiembre de 2024**: **heridas, ostomías y quemaduras**. Aplicables en AP, hospitales y 061. Registro con **NIC**: **2390 prescribir medicación**, **8100 derivación**, 5602 enseñanza del proceso de enfermedad, 7040 apoyo al cuidador; en heridas, 3660 cuidados de las heridas y 3584 tratamiento tópico.
- **Heridas** (todas las etiologías **salvo quemaduras**): registro objetivo; infección superficial o colonización crítica con **NERDS** y profunda u osteomielitis con **STONES**; heridas quirúrgicas según **Altemeier** (I limpia, II limpia-contaminada, III contaminada, IV sucia); UPP en grados I-IV; **LESCAH** (categorías 1A, 1B, 2A, 2B).

- **Ostomías**: valoración por **patrones de Gordon** y diagnósticos NANDA; escalas obligatorias: **NRS 2002** (riesgo **nutricional**), **Barthel** (autocuidado), **Gijón** (riesgo **social**) y **EVA** (dolor).
- **Quemaduras** (Unidad de Quemados de la Arrixaca): Gordon, Barthel, NRS 2002 y EVA; NANDA 00044, 00046, 00004, 00132. **Bromelaína (NexoBrid)**: desbridamiento enzimático de quemaduras de **2.º grado profundo y 3.º**; **2 g por cada 100 cm²**; lecho húmedo y **sin restos de antimicrobianos (la sulfadiazina argéntica la inactiva)**; **4 horas** de aplicación oclusiva y **sin segunda aplicación**; **máximo 15% de la superficie corporal** por sesión; contraindicada en alergia a la **piña o la papaína**; evitar en quemaduras químicas, eléctricas, por radiación, faciales o perineales; muy dolorosa; **uso hospitalario**.

6. Seguridad y responsabilidad

- La enfermera **no puede cambiar el principio activo** prescrito ni salirse de los márgenes del protocolo. Ante falta de respuesta, incumplimiento, interacciones o sospecha de RAM: **suspender**, registrar y **derivar** (NIC 8100).
- **Farmacovigilancia**: notificar al **Sistema Español de Farmacovigilancia** (Centro de Farmacovigilancia de la Región de Murcia) por **NotificaRAM** o Tarjeta Amarilla, **lo antes posible** (los 15 días naturales son el plazo de los **titulares** para las graves). Los colegios profesionales no tienen competencias en farmacovigilancia.
- En la receta electrónica: sin duplicidades, sin visados de inspección y **sin usar guías que no tengan protocolo regional** publicado. La firma electrónica vincula la responsabilidad.

TRAMPAS DE EXAMEN

! **La enfermera emite órdenes de dispensación, nunca recetas médicas.**

! Sin receta (art. 2) = autónomo; con receta (art. 3) = **guía + protocolo** y carácter colaborativo.

! La acreditación la concede la **Comunidad Autónoma**; el **REPS** solo la registra.

! INR de 1,5 = **subterapéutico**: no se da vitamina K, se sube la dosis.